

CAPÍTULO 9.6

Anemia por Déficit de Vitamina B12 y Folatos

PERFIL EUNACOM 1.071.006

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Talasemias

Definición

Hemoglobinopatías genéticas por alteración en la producción de cadenas globina de la Hb → **Anemia: Generalidades** anemia hemolítica crónica.

- **Alfa-talasemia:** afecta cadenas alfa → presente **desde el nacimiento** (la Hb fetal también usa cadenas alfa)
- **Beta-talasemia:** afecta cadenas beta → presente desde los **3-6 meses** (recién se sustituye la Hb fetal por adulta)

Diagnóstico

- **Hemograma:** anemia microsítica, pero con diferencias clave respecto a la ferropenia:

TABLA 9.6.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS		
	TALASEMIA	FERROPENIA
Tamaño de glóbulos rojos	Isocitosis (RDW normal; todos pequeños e iguales)	Anisocitosis (RDW ↑; tamaños variables)
Número de GR	↑ (a veces > 5-6 millones/mm³)	Normal o ↓
Perfil de hierro	Normal o sobrecarga	Ferritina ↓

- **Diagnóstico definitivo:** electroforesis de hemoglobina o cromatografía (busca Hb A2 ↑ en beta-talasemia) + análisis genético

Tratamiento

TABLA 9.6.2: SEVERIDAD VS TRATAMIENTO	
SEVERIDAD	TRATAMIENTO
Leve (rasgo talasémico)	Solo observar
Moderada	Transfusiones periódicas
Grave	Transfusiones + quelantes de hierro (para evitar hemocromatosis secundaria)

EUNACOM CRITERIOS

Hemocromatosis secundaria es una complicación frecuente en talasemias transfusión-dependientes → hay que quelar el hierro.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 68 años con antecedente de gastrectomía total hace 4 años consulta por astenia y parestesias en guante y calcetín en extremidades con inestabilidad de la marcha. Hemograma: Hb 8.2 g/dL, VCM 118 fL (macrocitica franca), Leucocitos 3.200/mm³, Plaquetas 110.000/mm³. Frotis sanguíneo: Neutrófilos polimorfonucleares hipersegmentados (pleocariocitos)."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Anemia Megaloblástica por Déficit de Vitamina B12: la gastrectomía total elimina la producción de Factor Intrínseco por las células parietales gástricas, agotando las reservas hepáticas de B12 en 3-5 años. Cursa con macrocitosis, pancitopenia leve, pleocariocitos y COMPROMISO NEUROLÓGICO (Degeneración combinada subaguda de la médula espinal). Tratamiento: Vitamina B12 (Cianocobalamina/Hidroxocobalamina) 1000 mcg IM diaria por 1 semana, luego semanal por 1 mes, y luego mensual de por vida.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Las talasemias son anemias microcíticas crónicas que se confunden con ferropénica
- Diferencia clave 1: isocitosis en talasemia (IDE normal) vs anisocitosis en ferropénica (IDE aumentado)
- Diferencia clave 2: glóbulos rojos aumentados en talasemia a pesar de la hemoglobina baja
- Alfa talasemia: presente desde el nacimiento. Beta talasemia: desde los 6 meses
- El diagnóstico se confirma con electroforesis de hemoglobina o análisis genéticos
- El perfil de hierro puede ser normal o mostrar sobrecarga (hemocromatosis secundaria)
- Tratamiento: observación en leves, transfusiones periódicas en graves, quelantes de hierro si hay sobrecarga

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ANEMIA POR DÉFICIT DE VITAMINA B12 Y FOLATOS)

PREGUNTA 1

Paciente con anemia microcítica, índice de dispersión eritrocitaria normal y recuento de glóbulos rojos de 6 millones/mm³. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Anemia ferropénica
- B)** Talasemia
- C)** Anemia sideroblástica
- D)** Anemia por enfermedades crónicas
- E)** Déficit de vitamina B12

PREGUNTA 2

¿A partir de qué edad se manifiesta la beta talasemia?

- A)** Desde el nacimiento
- B)** Desde los 3-6 meses
- C)** Desde los 2 años
- D)** Desde la adolescencia
- E)** In útero

PREGUNTA 3

¿Cuál es el examen confirmatorio para el diagnóstico de talasemia?

- A)** Perfil de hierro
- B)** Biopsia de médula ósea
- C)** Electroforesis de hemoglobina
- D)** Prueba de Coombs
- E)** Índice reticulocitario

RESUMEN: ANEMIA POR DÉFICIT DE VITAMINA B12 Y FOLATOS

Esta clase cubre las hemoglobinopatías, centrada en las talasemias y la anemia de células falciformes. Las talasemias son patologías genéticas con anemia crónica de severidad variable. La alfa talasemia se manifiesta desde el nacimiento y la beta talasemia desde los 6 meses de edad. Las talasemias se diferencian de la ferropénica por dos hallazgos clave: isocitosis (índice de dispersión eritrocitaria normal) versus anisocitosis en la ferropénica, y aumento del número de glóbulos rojos a pesar de la anemia. El diagnóstico se confirma con electroforesis de hemoglobina. Nota: El archivo de transcript correspondiente a la lección 06 contiene contenido sobre hemoglobinopatías (talasemias y anemia drepanocítica) que se superpone con la lección 07. El contenido de déficit de vitamina B12 y folatos no se encuentra disponible en el transcript proporcionado.